

Question 13: LE CANCER DU COL DE L'UTERUS

Evaluation 2025

Dr Khaled Trigui

1. Le cancer invasif du col:

- A. Est une maladie sexuellement transmissible
- B. Commence au niveau l'exocol quand le cancer est de type épidermoïde
- C. Passe obligatoirement par une dysplasie cervicale
- D. Peut être causé par une infection génitale basse par HPV 16
- E. Est d'évolution lente

2. La transmission du Papilloma Virus Humain (HPV) est favorisée par:
- A. Les rapports sexuels non protégés
 - B. Le tabac
 - C. la corticothérapie de longue durée
 - D. Les partenaires sexuels multiples
 - E. La co-infection par VIH

3. L'infection à HPV 16 peut être responsable de:

A. Verrues vulvo-vaginales

B. Cervicite

C. Cancer invasif du col

D. Condylomes anaux

E. Endométrite

4. Les sérotypes HPV à haut risque oncogène sont:

A. HPV 11

B. HPV 48

C. HPV 45

D. HPV 16

E. HPV 18

5. Concernant le processus de l'oncogénèse du cancer du col:
- A. Sa durée ne dépasse pas 5 ans
 - B. Il inclut une intégration du matériel génétique viral au niveau des cellules cervicales infectées
 - C. Les cofacteurs jouent un rôle secondaire
 - D. Les anomalies cellulaires débutent au niveau de la couche basale de la jonction pavimento-cylindrique
 - E. Le HPV joue un rôle dans l'initiation du processus

6. Les lésions cervicales à HPV visibles macroscopiquement:

- A. Dysplasie sévère
- B. Carcinome in situ
- C. Dysplasie légère
- D. Carcinome invasif
- E. Condylomes acuminés

7. La colposcopie permet de visualiser:

A. CIN1

B. CIN3

C. Carcinome in situ

D. Infection à HPV

E. Carcinome invasif

8. Les Lésions malpighiennes intraépithéliales de haut grade sont:

A. Dysplasie modérée

B. Dysplasie sévère

C. Carcinome invasif

D. Carcinome épidermoïde in situ

E. Dysplasie légère

9. Un carcinome classé micro-invasif peut présenter les caractéristiques suivantes:
- A. Infiltration de la membrane basale de 2 mm de profondeur
 - B. Présence d'embolies lymphatiques
 - C. Présence d'adénopathies iliaques externes
 - D. Présence de lésion de carcinome in situ associée
 - E. Présence de métastase à distance

10. Parmi ces propositions, les facteurs de risque d'un cancer du col sont:

- A. L'activité sexuelle non protégée
- B. La cervicite à chlamydiae
- C. La candidose vaginale
- D. La ménopause
- E. L'utilisation prolongée de la pilule microprogestative

11. Le saignement d'un cancer du col est habituellement:

- A. Abondant
- B. Provoqué
- C. Douloureux
- D. Continu
- E. Malodorant

12. Le diagnostic positif d'une lésion intraépithéliale de haut grade du col peut être fait par:

- A. Un FCU
- B. Une pièce de conisation
- C. Une pièce d'hystérectomie
- D. Une biopsie dirigée
- E. Un typage HPV oncogène positif

13. Lors de l'examen d'un cancer du col, le toucher vaginal permet d'apprécier :

- A. L'atteinte paramétriale
- B. L'atteinte des culs de sac vaginaux
- C. L'envahissement de la muqueuse rectale
- D. L'extension utérine
- E. L'extension vésicale

14. Le bilan pré-thérapeutique d'un carcinome épidermoïde in situ du col comprend:

- A. Un examen gynécologique sous AG
- B. Une hystéroscopie
- C. Un TDM pelvien
- D. Une consultation pré-anesthésie
- E. Une lymphographie pelvienne

15. Le bilan d'extension radiologique d'un cancer du col stade IB3 consiste en :

- A. Une radio thorax
- B. Une échographie hépatique
- C. Une scintigraphie osseuse
- D. Une IRM pelvienne et lombo-aortique
- E. Une échographie pelvienne

16. Le « Squamous Cell Carcinoma antigen » dans le cancer du col:

- A. Est un marqueur tumoral des adénocarcinomes
- B. Lorsqu'il élevé il indique une radiothérapie première
- C. Est un moyen de surveillance de l'efficacité thérapeutique
- D. Est positif dans les cancers épidermoïdes in situ
- E. Est un facteur de mauvais pronostic quand il est positif

17. Le cancer du col micro invasif stade IA :

- A. Est généralement asymptomatique
- B. Peut être associé à un test HPV négatif
- C. donne des métastases ganglionnaires
- D. Survient chez la femme très jeune
- E. Peut être traité par une radiothérapie seule

18. Une tumeur de 2 cm limitée au col, avec des adénopathies pelviennes associées, est classée:

A. IB1

B. IIIC1

C. IB2

D. IB 3

E. IIA1

19. Devant une CIN1 à la biopsie partiellement visible, la conduite à tenir est:

- A. Une conisation
- B. Une cryothérapie
- C. Un FCU après 12 mois
- D. Un traitement antiseptique local
- E. Une hystérectomie

20. La trachélectomie élargie peut être indiquée en cas de stade:

- A. IB1
- B. IB2
- C. IA1 avec emboles lymphatiques
- D. IA2 sans lymphatiques
- E. IA2 avec emboles lymphatiques

21. Le traitement du stade IB1 est:

- A. Colpohystérectomie élargie et une lymphadénectomie pelvienne (CHEL)
- B. Curiethérapie suivie CHEL
- C. Radiothérapie et curiethérapie
- D. Hystérectomie simple avec annexectomie bilatérale
- E. Trachélectomie élargie

22. La conisation du col utérin:

- A. Consiste en une amputation du col
- B. Est l'ablation de la jonction pavimento-cylindrique
- C. Est un moyen de diagnostic dans les stades avancés du cancer du col
- D. Peut être indiquée dans le traitement de certains carcinomes invasifs
- E. Est un moyen thérapeutique pour les cancers micro invasifs

23. La radio-chimiothérapie de première intention peut être indiquée dans le traitement des cancers du col suivants:

- A. Cancer invasif de 4 cm limité au col
- B. Cancer avec envahissement jusqu'au tiers supérieur du vagin
- C. Cancer invasif avec atteinte ganglionnaire pelvienne
- D. Cancer avec métastase à distance
- E. Cancer invasif de 1,5 cm limité au col sans adénopathies

24. La curiethérapie utéro-vaginale pour un cancer invasif du col :

A. En néoadjuvant, a pour but la réduction du volume tumoral

B. Stérilise les ganglions pelviens atteints

C. Est indiquée en première intention dans le stade IB1

D. Est indiquée dans le stade IIIC

E. Diminue le risque de récurrence local

25. La vaccination contre le HPV :

- A. Concerne les jeunes filles de 12 ans
- B. Elimine une infection en cours à HPV
- C. Comporte 3 doses pour les adolescents
- D. Diminue le risque de lésions malpighiennes de haut grade
- E. Offre une immunité définitive

26. La colposcopie :

- A. Est un examen du col au microscope
- B. Permet de visualiser le jonction pavimento-cylindrique pour optimiser la réalisation d'un FCU
- C. Evalue l'architecture du col
- D. Recherche une infection à HPV
- E. Est indiquée en cas de test HPV positif avec FCU normal

27. Devant un FCU montrant des anomalies malpighiennes de signification indéterminée chez une femme de 32 ans, vous devez faire:

- A. Une conisation
- B. Un FCU de contrôle dans 06 mois
- C. Une colposcopie et biopsie d'emblée
- D. Un traitement antiseptique local
- E. Un test HPV

28. Le dépistage organisé du cancer du col:

- A. Peut se faire pour les femmes qui n'ont jamais eu d'activité sexuelle
- B. Est à vie
- C. Commence par deux FCU consécutifs à 1an d'intervalle
- D. Doit intéresser la jonction glandulo-malpighienne
- E. Peut montrer une infection génitale basse

29. Le dépistage du cancer du col utérin recommandé pour une femme de 22 ans, nouvelle mariée:

- A. Un test HPV à l'âge de 22 ans
- B. Un FCU à 22 ans
- C. Un FCU à 24 ans
- D. Un test HPV à 30 ans
- E. Un FCU à 30 ANS

30. Le test HPV:

- A. Recherche les anomalies cellulaires cervicales en rapport avec une infection HPV
- B. Cible l'ADN viral du HPV dans le sang
- C. Indique une colposcopie quand il est positif
- D. Est recommandé pour les femmes à partir de 30 ans
- E. Est un frottis cervical et vaginal

31. Madame S, 54 ans, présente des atypies des cellules glandulaires au frottis de dépistage , votre conduite est:

- A. Colposcopie
- B. Conisation
- C. Test HPV
- D. Curetage de l'endocol
- E. Curetage biopsie de l'endomètre